جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ماجده شوقى عبدالخالق ابراهيم
المحافظة : الاسكندريه **الحي / المدينة :** اللبان **العنوان :** مممممممممممم
رقم البطاقة : 25603080104121 **رقم التليفون :** 01124772386 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 08-03-1956 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ماجده شوقى عبدالخالق ابراهيم
National ID: 25603080104121

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

21/4/2022

Name	ماجده شوقي عبد الحليم	MRN	٤٢٨٧/٢٠٢١
		ID	٢٥٦٠٢٠٥٠١٠٤١٠١
Age	66 y-	Phone	٠١١٢٤٧٧٢٨٦
Menopausal status		marital status	
OCP		Family history	
Co morbidity			

Clinical Data

Bx:

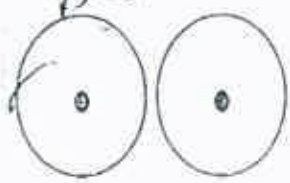
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
2/8	4/8	3+.	

Sonomammography :

Mets Workup:

incl. cT2, N3 in Pradu, mo

R BCS L



ypTcNM 1/1S +ccc.

Recommendations:

→ Read TCHP x 4 cycles stopped at PCR

- DVI, ↑ live-enzymes → RT BCS + ALN

MDT OUTCOME & PLAN

in view of partial pathological Resp ypN1/1S

For Adjuvat Kadayla x- 14 cycles + ~~Cont Suppl~~

- AI / SY

- PORT

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. الشيماء		د. أحمد	

21.4.22

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: ماجده شوقي عبدالخالق وفديه	
MR. : 5048	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 70-year-old individual with a history of locally advanced right breast cancer diagnosed in 2019 as invasive ductal carcinoma, grade II, ER 2/8, PR 4/8, HER2 3+. Initial treatment included TCHP chemotherapy for four cycles followed by radiotherapy to the breast and axillary lymph node dissection in April 2022. The patient experienced grade III toxicity and a deep vein thrombosis, leading to cessation of chemotherapy. Subsequent management involved two cycles of Kadcyla, which were discontinued due to elevated liver enzymes. The patient then received subcutaneous Herceptin for 17 cycles, followed by initiation of Femara in May 2022. The patient has been on Femara continuously through September 2025, with routine breast ultrasound, chest CT, full laboratory workup, and monthly Zometa 4 mg. Calcium supplementation with 1 mg daily and one alpha-hydroxy vitamin D dose were also prescribed.

The patient reports new complaints of vertigo and headache, prompting a plan for brain MRI and continuation of Zometa and Femara therapy. The latest imaging on 11 June 2026 includes a chest CT without contrast showing an enlarged mediastinal lymph node at the lower trachea measuring 1.6 cm, a fracture of the right 4th, 5th, and 6th ribs, bulky left suprarenal mass, and new suspicious lesions. The brain MRI remains pending. The patient's vertigo has improved with Betaserc, and visual blurring attributed to cataract has been noted prior to headache onset. The plan is to proceed with a comparison of the current CT chest with the previous study and to continue Femara therapy while awaiting further imaging and symptom assessment.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / ماجده شوقى عبدالخالق ابراهيم	Request No.	: 13005753
Patient No.	: 25603080104121	Request Date	: 06/04/2022
Path No.	: 953/2022	Verification Date	: 13/04/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
Age	: 66 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Rt breast cancer , post NACT
Nature of the specimen: WLE & ALND spicemen
Gross Examination:
1-ALND spicemen :fibrofatty tissue peice measured 10x7 cm enclosing 15 nodules up to 3x2 cm
2-Rt WLE excision spicemen:fibrofatty tissue peice measured 7x6x1 cm with no covering skin
• Tumor extent
o Number:An ill defined greyish white tumor bed site
o Size:2.5x2x2 cm
• Distance from margins:0.4 cm from superficial margin (least margin)
• Lymph nodes number and size:15 LN up to 3x2
• Frozen section:
-Free all resection margins
Microscopic examination:
-No remmenant of tumor tissue
• Lymph node involvement:(1/15) with extracapsular invasion
• Resection Margins:Free all margins
• Histologic response to therapy:Pathologic partial responce
Diagnosis:
Rt breast cancer , post NACT,WLE & ALND spicemen
-No remmenant of tumor tissue
-Free all margins
- LNs:(1/15) with extracapsular invasion
-Pathologic partial responce
-Stage :ypT0, ypN1

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / ماجده شوقى عبدالخالق ابراهيم	Request No.	: 13005753
Patient No.	: 25603080104121	Request Date	: 06/04/2022
Path No.	: 953/2022	Verification Date	: 13/04/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
Age	: 66 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Esraa Elgendy

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الاستاذه / ماجده شوقى عبدالخالق ابراهيم	Request No.	: 133441
Patient No.	: 25603080104121	Request Date	: 30/10/2021
Path No.	: SR-572/21	Verification Date	: 02/11/2021
Sex	: Female	Financial Category	: وزاره دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 65 Y	Department	: Out Patient
Referreing Docto:		IHC No.	:

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Right breast mass

Nature of the speciment:
Slide revision

Gross Examination:
' block by the patient's name and (7201-21-21) & 3 slides

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade II
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: N/A
- Resection Margins: N/A
- Histologic response to therapy: N/A

Diagnosis:
Right breast mass, Slide revision:
Invasive duct carcinoma grade II
IHC:
ER: Very weak nuclear reaction in about 10% of tumour cells. Negative, score (2/8)
PR: Weak nuclear reaction in about 30% of tumour cells. Positive, score (4/8)
Her-2: Strong complete membrane reaction in 10% of tumour cells. Positive, score 3+

Prof. Dr. Gamal Abd-El Aty
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

PATIENT NAME: **MAGDA SHAWKY ABDELHALK IBRAHIM** GENDER: **Female** AGE: **65 y**	PATIENT ID #: **2021166427** ORDER #: **1237875,1237876** DATE OF SERVICE: **23-Sep-2021 03:47 PM**

Report: - all studies

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

1-CHEST

- Right breast UOQ two intercommunicating irregular spiculated mass lesions with internal cystic degeneration the largest measuring19 X 14 mm.
- Enlarged right axillary level I and II lymph nodes the largest measures 31 X 23 mm.
- Prominent right axillary supraclavicular lymph nodes.
- Bilateral scattered pulmonary nodular ill defined opacities surrounded by faint ground glass opacities.
- Prominent right paratracheal and precarinal mediastinal lymph nodes the largest measures16 X 11 mm.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiomegaly.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows spondylotic changes more appreciated at D12 vertebral upper end plate.

Opinion:

- ***Right breast multiple malignant looking mass lesions with metastatic ipsilateral axillary lymph nodes and prominent right supraclavicaulr lymph nodes.***
- ***Bilateral scattered pulmonary nodular opacities, likely inflaminatory.***
- ***No definite evidence of hepatic or osseous metastatic deposits.***

Reported By,

Dr. Mohamed Mohsen, MSc
Dr. Mennatallah Mohamed, MD **23-Sep-2021 06:34 PM**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

PATIENT NAME: **MAGDA SHAWKY ABDELHALK IBRAHIM** GENDER: **Female** AGE: **65 y**	PATIENT ID #: **2021166427** ORDER #: **1237877** DATE OF SERVICE: **28-Sep-2021 12:54 PM**

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

FINDINGS:

Mild degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Otherwise, the rest of surveyed skeleton is free from definite hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **29-Sep-2021 04:36 PM**

www.baheya.org 16602 4 شارع علوية - الهرم - خلف مركز دايو
Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]